

Pr louzi 2

Donc, si vous avez des questions sur le cours, le premier cours, vous pouvez l'écrire et on va le discuter. Sinon, vous pouvez prendre la parole et puis on va discuter. Donc, on aura ici trois cas cliniques avec la discussion sur le cours et deux cas cliniques sur les deux ou trois sur le cancer du pancréas.

On va essayer de faire quarante-cinq minutes, quarante-cinq minutes ou bien quarante minutes, quarante minutes et on laissera dix minutes pour la discussion. On peut même tarder un petit peu si vous voulez. Si vous avez des questions sur les autres cours, je suis là.

Pas de souci. Y a-t-il un volontaire pour le premier cas? Please. Mais je n'ai pas de retour.

Vous pouvez lire, professeur. Allez-y. En tout cas, c'est affiché.

D'accord. Monsieur R, 76 ans, se présente pour des douleurs abdominales d'installation brutale avec des vomissements. Ayant comment précédent un infarctus du myocarde il y a sept mois.

Donc, c'est le même cas clinique qu'on faisait dans l'enseignement dirigé. On prend. On prenait.

Normalement, on prenait notre temps pour discuter. D'accord. On discute tout.

Donc, les douleurs abdominales d'installation brutale, c'est un abdomen presque aigu. Donc, on va enregistrer. Je vais essayer de le faire.

Enregistrer. Younes. Younes.

Comment on l'a enregistré? Ils veulent qu'on l'enregistre. Les trois. Latin.

Où est-ce qu'il est? Il est fait. Donc, c'était enregistré. D'accord.

Ok, c'est fait. Donc, on a un abdomen aigu. On fait un interrogatoire depuis quand il a mal, c'est ça? Ferdos, tu es avec moi? Oui, professeur.

D'accord. On demande tout, c'est-à-dire qu'un abdomen aigu, que ce soit sur la peritonite, l'appendicite, toutes les étiologies, toutes les douleurs abdominales. J'avais fait un article.

C'est rare de trouver un article sur les douleurs abdominales. C'est très difficile à gérer. Nous, on sait la chose parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose qui est mortel.

Par exemple, une peritonite, il y a des gens qui peuvent décéder en quelques heures lorsqu'ils ont une peritonite évoluée. Par contre, on en a parlé l'autre fois, c'est qu'il ne faut pas laisser passer une urgence chirurgicale, mais surtout, il ne faut pas opérer parce que les douleurs abdominales, le plus souvent, elles sont bénignes. Il y a pas mal d'étiologies, que digestive, thoracique, gynécologique, urologique.

Ça peut se solder par des douleurs abdominales. Il y a des gens qui n'ont rien et parfois, ils ont des douleurs qui sont psychogènes. Donc, on va être sûr d'accord.

La particularité, lorsqu'on va demander sur le patient, on va trouver que dans les antécédents. Et là, un infarctus du myocarde, il y a sept mois, traité. Il est âgé, il a des douleurs abdominales.

Vas-y, terminé. Donc, lorsqu'on fait l'interrogatoire à l'examen, allez-y. À l'examen, on trouve une fréquence cardiaque à 84 battements par minute, une tension artérielle C9, une fréquence respiratoire à 18, une température à 37,8, une défense abdominale généralisée, le toussé rectal montre une ampoule rectale vide avec un doigtier souillé de sang.

C'est quoi les éléments péjoratifs dans cette observation? Donc, 76 ans. Donc, il était bien. Il a un antécédent.

On lui demande est-ce que vous êtes diabétique, hyper tendu? D'accord, oui, par-ci, par-là, non. J'avais des douleurs comme ça, je prenais les antartiques, j'avais ça, mais j'étais bien, indépendant, pas de souci. J'avais un problème cardiaque il y a six mois.

On a diagnostiqué un infarctus du myocarde. On m'a traité, j'ai pas de problème, je suis indépendant. Je bouge, je fais mes activités physiques journalières.

Et après, maintenant, depuis 24 heures, j'ai eu mal au niveau du ventre. Et puis, à l'examen, lorsque vous faites tout l'examen avec l'interrogatoire, vous trouvez ça. C'est quoi les éléments qui sont péjoratifs ici, Ferdows? La défense abdominale généralisée.

D'accord. Avec la tension artérielle qui est enlevée et l'antécédent d'un infarctus du myocarde. D'accord.

Autre chose? La douleur qui s'est installée brutalement. C'est ça, mais surtout, il y a la défense, mais il y a autre chose. La défense, c'est capital, parce qu'on a dit que la défense, c'est pas un abdomen souple, c'est pas une sensibilité.

D'accord. Lorsque j'ai un doute, pas de souci, mais la défense, c'est vraiment, c'est objectif. C'est la contraction qu'on a. Si jamais vous sortez avec ce message, dans les urgences, dans notre service, vous arrivez à examiner les gens qui ont une appendicite, une péritonite, ou une irritation péritoniale en post-opératoire, si vous sortez avec l'examen d'une défense et un doute, c'est un examen objectif, c'est la meilleure des choses.

Par contre, il y a un autre élément qui est très important, c'est le toucher rectal. Regardez ici. Oui, le doigtier qui est souillé de sang.

C'est ça, c'est très important, parce qu'il peut vous rapporter les mélénas. Lui, maintenant, ça c'est très péjoratif. Vous trouvez qu'un doigtier où il est très bien nourri, c'est ça.

D'accord, mais vous pouvez intervenir. On peut parler. J'aurais aimé, d'accord.

Ils ne font pas les caméras ici, mais pas de souci. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va demander une aide.

D'accord, vous êtes d'accord ? Il y a un autre avis ? L'auscultation. L'auscultation, on n'a rien trouvé. Mais ça manque, c'est vrai.

C'est que l'observation ici, on va tout faire. L'auscultation, la percussion, tout ce que vous voulez, l'examen, l'interrogatoire, ça va prendre un quart d'heure à 20 minutes. Mais ce qu'on a, c'est l'observation, le résumé, la conclusion clinique, c'est que le patient, il a 76 ans, il a un antécédent d'infarction du myocarde qui a été géré, traité, et puis il a un abdomen aigu, douleur abdominale depuis 24 heures aiguë, d'installation brutale avec une défense et un doigtier qui revient sur les sons.

Les constantes hémodynamiques, c'est vrai, ils sont normaux. Ce n'est pas un patient qui est choqué. On est devant un abdomen aigu.

La première des choses à demander, c'est une radiographie d'abdomen sans préparation. J'ai vu tout à l'heure. Je peux demander un ECG à la recherche d'une cardiopathie embolisée, puisqu'elle a déjà un antécédent d'infarction du myocarde.

Un ECG, c'est ça ? Oui, professeur. Non, mais on est dans l'abdomen aigu. Vous allez demander tout, demander après, mais on va demander en premier un ASP.

Oui, après l'ASP. Non, mais maintenant, je cherche, je n'ai pas encore le diagnostic. Je n'ai rien maintenant.

Ça peut être tout, une défense avec un doigt, ça peut être tout. Ça peut être une tumeur qui a perforé, ça peut être tout. Dès que je suis avec une défense, je vais demander un ASP.

L'ASP, qu'est-ce qu'il a montré ? C'est ça. Il a montré des niveaux, il n'y avait pas de tumeur péritoine. Il y a des niveaux, c'est-à-dire que vous avez comme sorte d'une irritation du cœur, mais je n'ai pas le diagnostic.

Il n'est pas en occlusion. Pour faire le diagnostic d'une occlusion, on a une grisaille diffuse, en tout cas des verges qui sont un petit peu floues, et des niveaux, quelques niveaux. Sinon, ça peut être normal.

On peut demander maintenant un scanner. On a demandé un échographie. Maintenant, si jamais l'ASP a montré un pneu péritoine, on est devant une urgence chirurgicale.

C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une solution de continuité d'un organe cru abdominal. On est obligé d'opérer. Sinon, on peut demander autre chose.

On a demandé même une échographie, à la recherche d'un épanchement, quelque chose. Ici, dans les esquimales intestinales aiguës, on a dit que l'échographie avec l'écodoptère, elle est très importante pour chercher les épanchements, une urologie, autre urologie, ou bien les vaisseaux qui sont... Même l'échographie, elle était normale. Et on va demander, on va arriver à ce que tu dis maintenant.

On va demander un scanner abdominal. Ce scanner-là, on l'a dans le cours. Ça fait quelques années que je le mets, maintenant plus de dix ans.

C'est le signe. On a les niveaux hydroériques. On a une pneumatisation de la paroi.

On peut trouver parfois un pneume péritoine. Ici, on a une souffrance intestinale. Niveau hydroérique, très bien, avec une pneumatisation.

Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Demander l'artériographie. L'extantérique.

On peut la demander, mais... Oui, signe de souffrance intestinale, mais il n'y a pas d'indication ici. C'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion radioclinique ici? Il y a une perforation de l'organe creux, de l'anus. On n'est pas encore dans la perforation, mais dans la souffrance intestinale.

Ça a été dit par Shadi Ihsan. Très bien. C'est que moi, j'ai un patient avec un abdomen aigu, avec une défonce, un doigtier qui revient sous le sang.

Et puis, quand je fais la radio, la SP, quelques niveaux, mais surtout le scanner qui montre des signes de souffrance, qui est la pneumatisation avec des niveaux hydroériques. Ce patient-là, on va l'opérer. On peut demander rapidement une consultation préalitique, le CG pour voir rapidement, en quelques secondes, on le fait.

On peut demander un bilan, un bilan qu'on va récupérer pour le mettre en condition, mais c'est une indication opératoire. J'ai tous les éléments. J'ai pas un ASP normal.

J'ai pas un scanner normal. J'ai tout. J'ai un abdomen qui est très suspect.

On va opérer le patient. Ce patient-là, tu peux pas le laisser. Tu peux pas le laisser pour 4 heures, 5 heures ou bien jusqu'au lendemain.

Il va faire une péritonite sacculaire. Ça, c'est le cas typique que l'on reçoit dans nos urgences. Même dans ma thèse, c'est la majorité des patients que l'on a. Voilà le patient.

On va l'opérer. D'accord, on a demandé un scanner. Le même scanner, lorsqu'on voit en haut, on voit de l'air dans les vaisseaux, dans les veines portales au niveau du foie.

On parle d'aéroporti. Mais ça, c'est un signe de gravité. Oubliez-le.

Vous pouvez la voir parce que vous pouvez la voir. C'est un terme médical. Vous allez l'utiliser dans votre vie.

Et le patient, on va l'opérer. Et lorsqu'on l'a opéré, c'est le même patient. Lorsqu'on l'a opéré, qu'est-ce qu'on a trouvé comme ça ? C'est la première image que je vous montre pour être choqué.

Les mêmes cas, c'était les mêmes observations que l'on a vues au niveau de la péritonite. Il y a des différences près. Mais ici, on est devant un infarctus mésentérique.

C'est le tableau typique d'un infarctus mésentérique. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La résurrection de l'intestin qui est nécrosée. C'est le même.

Il y a une partie d'onces intestinales qui sont de coloration presque normale. Il y a une limite avec la nécrose. C'est que la nécrose intestinale, c'est la mort intestinale.

C'est acquis. On est obligé de couper la partie nécrosée des onces intestinales. Au stade de la nécrose, c'est irrécupérable, l'once intestinale.

Ici, on vous enseigne que ça dépend des conditions locales. On peut faire une anastomose. On peut réséquer.

On veut faire une stomie. La stomie, vous allez la voir dans les services. C'est l'abrochement d'un segment du tube digestif à la paroi.

On a des stomies d'évacuation et on a des stomies de nutrition. On peut faire une stomie pour s'alimenter. Quelqu'un qui a un obstacle ici au niveau du dosage, on va dépasser l'obstacle et faire une gastrostomie pour qu'il s'alimente.

Ici, on est obligé d'avoir une stomie d'évacuation. Il y a des études récentes sur ça. Il y a pas mal de choses que l'on fait.

On peut stomiser, non-stomiser, situer. On peut faire autre chose, mais ça, c'est très compliqué. C'est hyper spécialisé.

C'est une pathologie qui est gravissime. C'est un pronostic très fâcheux. Les gens qui font les thromboses au niveau intestinal, c'est des gens qui, le plus souvent, sont âgés.

Ils ont des complications après-vasculaires. On ne les rattrape pas. On essaie de les rattraper.

C'est pourquoi le cours s'est dit qu'on aurait aimé faire le diagnostic avant l'installation de la nécrose intestinale. Maintenant, la vascularisation mésentérique supérieure, c'est une vascularisation au niveau de l'once, de l'intestin et du côlon droit. C'est une vascularisation presque terminale.

C'est vrai qu'il y a les acates. Lorsqu'on a un thrombus au niveau de la racine, au niveau du début de la terre mesenterique supérieure, c'est que tout le test ingrédient qui va être souffrant, qui va être nécrosé. Lorsqu'on a une branche terminale, c'est la partie concernée de l'once intestinale qui va être nécrosée.

Et puis, maintenant, quand on prend un autre temps, c'est que les ischémies, vous commencez à les comprendre. On peut avoir une ischémie au niveau de la tête, une ischémie au niveau du coeur dans les coronas, une ischémie au niveau des membres inférieurs. Et dans chaque spécialité, vous avez des ischémies, surtout des vaisseaux qui sont terminaux.

Ici, il y a pas mal de physiopathologies au niveau de l'artère mesenterique supérieure. Il y a l'artère et il y a même la veine, parce que vous avez dans les histiologies, les histiologies artérielles, les histiologies veineuses et les histiologies sans lésions vasculaires. C'est dans le cours.

On va voir ici qu'est-ce qu'il y a. Ici, c'est la même chose pour l'artère mesenterique supérieure. Ici, pour vous expliquer que le colon, on peut avoir des colitis chimiques, mais c'est très rare, c'est des gens qui sont âgés, qui ont des problèmes vasculaires avec l'âge, avec l'arthrosclerose, ils peuvent faire des colitis chimiques. Mais le plus souvent, le colon, il est protégé par cette arcade-là.

C'est ce qu'on appelle l'arcade paracolique de Riholand. C'est pourquoi, lorsqu'on a une infection de l'artère mesenterique inférieure, on peut avoir une suppléance de l'artère mesenterique supérieure. C'est pourquoi les ischémies intestinales aiguës, ils intéressent surtout le système mesenterique supérieur.

Donc, vous avez les différentes étapes, c'est dans la physiopathologie ancienne. Nous, on a été élevés, et les étudiants l'ont montré. L'ischémie, elle dépend de plusieurs choses.

De la rapidité de l'installation de l'ischémie, et du type de la lésion vasculaire. Est-ce qu'elle est complète ou non complète ? Par exemple, une embolie qui vient obstruer tout le vaisseau, c'est une chose. Un petit embole qui prend 100 ans, ça va donner un autre tableau.

Une atteinte artérielle, c'est pas une atteinte veineuse. Donc, c'est très différent. Mais, lorsqu'on travaille dans le ventre, lorsqu'on a les ans, lorsqu'on les mobilise, c'est que le vaisseau, on le serre, ou bien on le met dans une position inconfortable, comme ça qu'il est obstrué.

La lance intestinale devient un petit peu pâle, grisâtre. Il commence à souffrir un petit peu, et après, il commence à être paralysé. Et lorsqu'un stade avance, on aura la muqueuse, parce que dans la muqueuse, il n'y a pas de vaisseau.

Les vaisseaux sont dans la musculieuse et la sussureuse, surtout dans la sous-muqueuse plutôt. La musculieuse, c'est elle qui est atteinte, parce que les cellules sont très sensibles à l'ischémie.

Donc, ça va commencer, et la lésion muqueuse qui va.

Et après, on aura la lésion de toute la paroi. Et après, la nécrose, ça devient rougeâtre, rouge foncé, noirâtre, et après, on aura une perforation. Donc, le tableau, c'est le même de toutes les... À part les composants vasculaires, on aura les lésions paritales.

On aura le contenu au niveau du grêle, qui va passer, ce qu'on appelle, ça peut passer par les pores microscopiques, on parle de translocation. On aura un troisième secteur, un épanchement au niveau du ventre, ça va faire un troisième secteur, avec des déperations éliquidiennes et électrolytiques, hydroélectrolytiques. Libération des facteurs toxiques systémiques.

Et on aura un système grave, sinon un état de choc. C'est pourquoi on les opère en urgence. S'il vous plaît, professeur, qu'est-ce qu'on trouve dans les examens complémentaires au début de l'esquimier ? D'accord, au début, on va parler de ce tableau-là.

Parce que, maintenant, le premier cas, c'est un problème d'infarctus mésentérique. D'infarctus, ou bien infarctus, infarctissement, ça c'est anapate. Et avec le temps, c'est ça, c'est le cours.

Mais après, on a changé le titre. On l'appelle esquimier intestinal aigu avec deux tableaux. On va y arriver.

D'accord ? On va arriver à votre question. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ? Sinon, on va passer au deuxième cas clinique. Un volontaire.

S'il vous plaît, rien que lire, pour lire. Myriam, Hasna, Ghalia, Aya, Salwa, Ayoub Ben Mansour. C'est Ayoub.

Ayoub. Un volontaire. Monsieur, je lis.

Allez-y, Hasna. Madame F, 38 ans, présente des douleurs abdominales depuis 8 heures, paroxysme, vomissement et un épisode de diarrhée. Antécédents, suivi de précisions mitrales.

À l'examen, on trouve un abdomen plat, sensible, bruit hydrophonérique accentué, toucher rectal normal, auscultation cardiaque, trouble du rythme cardiaque et souffle mitral. C'est-à-dire que nous, le cas clinique, on prenait notre temps. C'est-à-dire qu'après ça, on prenait 20 minutes, 30 minutes à discuter entre nous.

C'est ça. L'intérêt, c'est de sortir parce que le plus souvent, ces patients-là, on ne fait pas le diagnostic à un stade précoce. On les voit, on leur dit écoutez, vous n'avez rien, vous avez mangé quelque chose, c'est une intolérance, une gastroentérite.

On va donner un antispasmodique, surtout avec la diarrhée. Depuis 8 heures, qu'est-ce que vous avez mangé ? J'étais à l'extérieur, j'ai mangé quelque chose. Vous avez ça, on va donner ça.

Mais lorsqu'on a approfondi l'interrogatoire et l'examen clinique, on peut suspecter quelque chose.

Cette patiente, elle a un problème cardiaque, un problème de rétrécissement mitral avec des troubles de rythme. On va donner ça, d'accord ? C'est des gens qui font ça.

Et après, il y a l'abdomen, il est vraiment un petit peu sensible, mais il n'y a pas de défense. Par contre, il y a une exagération. Une exagération des bruits hydro-aériques, et puis le touché rectal, il n'y avait pas de méléna.

Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Un ASP, une échographie. Moi, j'ai demandé une échographie. Un ASP, je n'ai pas des éléments, je n'ai pas de défense, je n'ai pas de contracture, je n'ai pas.

On va demander une échographie. On va demander une échographie, mais ECG, oui, on va le demander par la suite, d'accord ? Mais on est dans le diagnostic, on est en... C'est vrai que c'est très difficile, on peut faire ça, parce que déjà, on a trouvé les troubles à l'auscultation. C'est des gens, le plus souvent, qui sont suivis en cardiologie.

Est-ce qu'ils sont sous traitement ou non ? D'accord, on peut demander ça, on peut demander, mais il est dans le raisonnement clinique de ce cas-là, on va demander une échographie. Mais... Mais qu'est-ce qu'on va dire aux radiologues ? On va la faire, mais surtout, qu'est-ce qu'on va dire aux radiologues ? C'est vrai qu'à l'échographie, on va chercher des choses qui sont, des signes qui sont de gravité, un épanchement, une autre étiologie, d'accord ? Si par malheur, je trouve une visioclinique diazique, je vais dire que, probablement, c'est une pancréatite. Si je trouve un calcul au niveau rénal, je vais dire que, probablement, elle ne sait pas décrire sa douleur, et c'est probablement une colic néphritique.

Mais ici, c'est non. C'est pourquoi il faut demander, parce que je suis devant une urgence, je dois éliminer une urgence, d'accord ? Une urgence thérapeutique. On va demander l'échographie.

L'échographie normale, elle est normale. L'échographie, il n'y a pas d'épanchement. Les ongles intestinaux sont de paroi normale.

Il n'y a pas d'autre étiologie. Par contre, pour la radiologue, il faut leur demander un échodoplaire. Parce que, toi, tu es devant un abdomen aigu.

Il a très mal. Il a un problème de troubles de rythme. J'inspecte une ischémie intestinale aiguë à son début.

C'est ça, on va demander un échographe abdominal avec un échodoplaire. Et, parfois, c'est très difficile, mais les gens, lorsque vous avez des gens qui sont formés pour ça, ils peuvent chercher les thrombus. Ici, ils ont trouvé un thrombus.

Un thrombus, ici, au niveau de l'artère mésentérique supérieure. Il y a les flux vasculaires qui sont bleus et rouges, mais ici, il n'y a pas de flux. Professeur, s'il vous plaît, est-ce que

l'échodoplaire peut objectiver ce thrombus lors de l'ischémie intestinale au début ? Pardon ? Répète la question, s'il vous plaît.

Est-ce que l'échodoplaire permet d'objectiver de façon fréquente la présence du thrombus ? Non, non. Non, c'est très difficile. C'est très difficile.

C'était très difficile. Ça devient moins difficile. Moi, je vous dis autre chose.

Heureusement, c'est vrai qu'on l'enseigne, parce que ça existe. Parce qu'on enseigne les différentes ischémies, l'ischémie cérébrale, cardiaque, d'accord ? Mais, quand même, cette pathologie, elle est très rare. Et il n'est pas du tout facile de faire le diagnostic.

C'est très difficile de faire le diagnostic, mais on l'enseigne parce qu'avec le temps, on aura ça, parce qu'on aura des troubles de coagulabilité qui sont très fréquents, mais c'est très difficile. C'est très difficile de faire le diagnostic. Et lorsque, parfois, on a le doute, on va demander le scanner avec un mange-scanner.

Mais nous, on vous enseigne l'hierarchie des examens. C'est très difficile pour vous convaincre, même parfois pour convaincre le patient. Si j'ai un échographiste qui est très fort, la patiente est mince, on va le faire rapidement, on va demander une échographie, avec un échographiste qui est très bien, avec un échographiste qui est très bien, et on va demander l'échographie, il va vous dire normal, mais on demande à vérifier les axes mésentériques.

Mais parfois, on a le diagnostic. Il y a des gens qui nous font le diagnostic. Donc, on peut, on a ça, on peut demander même un scanner pour voir ici, comme ça, une obstruction au niveau de la naissance de l'artère mésentérique supérieure.

Et maintenant, l'échographie, surtout l'échographie l'échodoplaire, il va montrer au niveau de l'origine de l'artère mésentérique. Il ne peut pas le montrer dans les segments un petit peu d'aval des branches mésentériques supérieures. OK.

Ici, lorsqu'on a un cœur, mais maintenant, ça se fait, parce qu'on a, maintenant, c'est les radiologues interventionnistes qui font ça. Et lorsqu'on a un doute, on va demander une artérographie. Et l'intérêt de l'artérographie, de la radiographie, c'est de faire le diagnostic, mais surtout d'essayer de faire le traitement.

Ce qu'on appelle la thrombolise. On essaie de liquifier, d'enlever le caillot. Ça peut être mécanique.

On introduit une petite cendre avec un ballonnet, et on le gonfle, on fait sortir le thrombus. OK. Sinon, on peut injecter une substance qui va liquifier le thrombus.

C'est pas de la science-fiction. C'est de la... Non, on essaie d'arriver à la question des récidives. C'est simple, la réponse, elle est simple ici.

Mais ici, on est devant l'urgence. C'est-à-dire qu'on va traiter la lésion vasculaire avant l'installation des dégâts intestinaux. Avant la nécrose intestinale.

OK. Et après, et après, on va demander, le principe, dans toutes les pathologies qui sont qu'on appelle thrombolytiques, thrombotiques, on donne des médicaments qui liquifient le sang, l'asthme, le syndrome, les antivitamines K. Et puis maintenant, il y a d'autres substances comme le plavix, ça, vous allez l'étudier en cardiologie. Donc, évaluer le risque des récurrences, c'est que lorsqu'on a des pathologies qui sont embryogènes, qui sont thrombotiques, on donne un traitement pour ne pas avoir de thrombus dans tout le corps.

Si le corps est normal, le tableau clinique est pauvre, la saison est complète. Lorsqu'on a un doute, on va terminer par un angescan et une orthographie. Le problème, c'est que dans tous les articles, moi j'avais tout le temps, maintenant, je l'enseigne depuis 2003.

2003, j'enseigne ce cours-là. C'est moi le seul qui l'enseigne. J'avais tout le temps, et même dans les congrès, j'avais tout le temps, et même, tout le temps, de justifier ces examens-là.

Il faut savoir que l'orthographie, c'est un geste qui va demander une salle de radiologie comme un bloc. C'est un... Le tableau que je trouvais dans les articles lorsque je faisais les recherches, c'est un examen qui est quand même, c'était un examen grossier. Le terme grossier, ça sortait dans les articles.

Mais c'est pas ça. C'est que si vous êtes convaincu, vous avez tout le tableau, la patiente, vous avez la trémale, et vous, vous suspectez un thrombus, il faut faire l'orthographie. Pour faire le diagnostic, mais surtout pour faire le geste.

Parce qu'on va faire un traitement ondivasculaire. En tout cas, ça c'est dans l'artère, dans la veine, c'est un petit peu compliqué. Dans la veine, on va donner les traitements par voie orale pour liquifier le thrombus.

Ok. Ici, c'est l'artère, le début de l'artère. L'artère mésentérique, le début.

Ça peut être un thrombus, ça peut être un... un embôle, ça peut être... ça peut être une... comment on appelle les autres? C'est du calcaire qui est à l'orifice. On peut l'enlever. Ça c'est le traitement ondivasculaire.

Lorsqu'on ne peut pas, il y a le traitement chirurgical. On opère les jambes, on opère et on prend ce vaisseau-là, on essaie de le costumer, comme un pontage, comme le pontage que l'on fait dans le coeur. On fait un petit pontage.

On prend un bout de... un bout de veine, ou bien une prothèse veineuse, et on va essayer de l'aboucher ici, sur l'aorte, et une partie qui est normale de l'arthérisantérique. Et on aura un co-circuit, ce qu'on appelle un pontage vasculaire. Ça c'est le traitement vasculaire.

Dans les ischémies, on a le traitement digestif des onces et puis le traitement vasculaire. S'il vous plaît, est-ce qu'il faut recherche? Oui, oui. Oui, vous avez la recherche étiologique? Dans les étiologies, vous avez les étiologies artérielles, veineuses, et non-vasculaires.

Donc, lorsqu'on a un thrombus, on essaie de chercher l'étiologie. Ici, on a un problème de cénose mitrale avec une oreillette qui était très distendue. C'est là où ça donne beaucoup d'emballes.

Enfin, on va essayer de trouver, faire le co-cœur, chercher le thrombus, et après, surtout, donner un traitement qui est prophylactique pour éviter une récurrence ou une autre ischémie. Regardez ça, dans le cours, c'est que maintenant, ça, c'est une pièce d'autopsie. On trouve ici la terre misanthérique qui a un thrombus, comme ça, très lent.

Est-ce qu'il faut rechercher l'origine du thrombus, par exemple? Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Un autre volontaire? Rapidement, parce que... Allez-y.

Allez-y. Fermeture. Donc, ces concisants se présentent aux urgences pour des douleurs abdominales depuis une semaine.

Ça, c'est pas... 24 heures, c'est pas... D'accord, depuis une semaine. Des vomissements, une diarrhée semblante. Donc, des fonces abdominales généralisées.

Un bon état immunologique. Donc, on aura le temps de l'explorer. L'ASPRS, l'échographie qui montre un épanchement abdominale de faibles urgences.

Ici, on a un épanchement. Et là, une défense. Donc, depuis une semaine, donc, des douleurs, vomissements, diarrhées sanglantes.

Il y a un petit peu de son. Donc, et des fonces abdominales généralisées. D'accord.

On a échographié un épanchement de faibles abondances. Maintenant, on peut l'opérer. Sinon, on peut demander un scanner.

Un scanner, on aura ça. On aura ici, regardez, le thrombus. Mais surtout, les onces ici.

Avec l'épanchement et la souffrance, les onces intestinales qui ont une paroi épicée. On ne peut pas interpréter cette clarté-là comme pneumatose, comme pneumatisation de la paroi. Mais on a tous les éléments pour opérer ce patient.

Ici, ici, on parle de la veine. Le plus souvent, le tableau de thrombus de la veine, ça prend un petit peu de temps. C'est pas comme l'artère.

L'artère, c'est pas comme l'artère. C'est, c'est la veine. Ça prend un petit peu de temps pour avoir des lésions.

Vous allez voir ça. On n'en a pas. On parle.

Il y a un infarctus, il y a un infarctissement. C'est pas... Nous, on l'a étudié. Mais je ne suis pas très qualifié pour vous faire la part des choses.

Mais il y a une grande différence entre les... D'accord. Ici, ça, c'est l'aspect. C'est pas comme tout à l'heure.

Ça, ça sortait pas. Mais c'est l'aspect. On le trouve dans les infarctissements veineux.

On trouve une écrose, mais avec une paroi épiciée. Un colorant aussi un petit peu noirâtre. Vers le rouge.

Combien de temps on en a pour faire les examens de ce complexe d'infarctus? Mais si, déjà le patient, le tableau, ça a évolué depuis une semaine. Il a une défense. Ça a pris le temps.

Il y a... En tout cas, parce qu'ici, on a la défense, on a l'aviaire sanglante et on a l'épanchement à l'échographie. On a des signes de souffrance intestinale au scanner avec un épanchement. On a peur.

Si vous pouvez, le transit intestinal reste normal lors du screening. Oui. Oui, tout à l'heure, oui.

On va voir les deux tableaux comparatifs. On va. Et ça reste.

Mais parfois, tellement évolué, vous trouvez avoir une paralysie lorsque vous avez une... D'accord. Avec une évolution un petit peu longue, on peut avoir une occlusion. Mais les gens, la majorité, ils conservent leur transit.

Parce que les ongles intestinaux, ils se défendent. Ils ont un péristarxisme qui est conservé. Ce que je vous dis, parce qu'il y a tous les éléments pour opérer le patient, parce qu'on a peur d'une nécrose avec une péritonite.

C'est quoi, là? Une translocation bactérienne et une péritonite. Ça, c'est une image de la tasse d'une autopsie. C'est pas grave.

D'accord, mais le patient, on va l'opérer et on va trouver... On l'a opéré, on va faire une résection intestinale. On peut anastomoser. Ou bien on peut stomoser.

Il y a autre chose parce que... On disait que c'était ancien, mais c'est pas ancien. C'est qu'on peut opérer les gens et on peut partir les revoir le lendemain. Après 24-48 heures, on voit si les ongles sont bien vivantes ou non.

Parce que c'est un pronostic qui est très fâché. Voilà la question de départ. C'est ce tableau qui était très important à faire la part des choses.

C'est que il y a une grande différence entre une ischémie intestinale débutante et une ischémie intestinale 1 au tableau d'infarctus mésentérique. Ici, la douleur, elle est brutale et parasitique. Ici,

elle est continue et diffuse un certain nombre.

Ici, on aura des vomissements. Ici, on aura des diarrhées sanglantes. Ici, on aura des diarrhées comme ça, mécaniques.

On peut avoir, comme la question de tout à l'heure, on voit au stade utile, une occlusion, un syndrome occlusif. Donc, l'examen ici, dans l'ischémie intestinale, il n'y a pas de défense. Il y a un hyperparasite.

Il y a une sensibilité abdominale. Il n'y a pas de défense. Les bruits hydrauliques qui sont situés et le toucher rectal, c'est normal.

Ici, c'est tout le contraire. On aura un abdomen un petit peu gonflé, un petit peu ballonné, une défense abdominale et surtout, on n'aura pas des bruits hydrauliques exagérés. On aura un silence abdominal et le toucher rectal.

S'il vous plaît, en pratique, est-ce que vous préférez ? Non, non, ça dépend. Ça dépend. Je ne voulais pas vous dire la meilleure étude qui date de quelques années, 3 à 4 ans.

C'est que les gens, il n'y a pas que ces deux techniques, stomy ou suture, mais ça dépend. Lorsque j'ai une écrose limitée avec le reste des ongles qui sont bien, on peut faire la stomie. Un abdomen, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de pus, il n'y a rien.

On ne fait pas de suture en milieu septique. Lorsque j'ai un abdomen qui est propre et tout ça, je vais essayer de faire la suture. Ce n'est pas un choix.

C'est une conduite que l'on fait suivant des critères bien particuliers. C'est vrai que ça reste humain, la décision, ça émane du chirurgien ou bien de l'équipe ou bien à l'état des patients. Lorsque vous avez un patient qui a un problème général, un état hémodynamique instable ou autre chose, on ne va pas faire la suture parce qu'on risque d'avoir une péritonite post-opératoire.

Ce n'est pas un choix. Je préfère. Comment je fais? Je préfère faire, mais ça dépend.

Je préfère, c'est en fonction. Je préfère sauver le patient. Mais si j'ai un patient qui est bien, pourtant, tous les conditions, je vais essayer de le suturer.

Un volontaire, l'infarcture médicale peut-elle se révéler par? Répondez par les messages. A, B, C, E. Très bien. Donc occlusion intestinale, état de choc, péritonite aiguë, diarrhée sanglante.

A, B, C, E. Très bien. Parfait. L'ischémie intestinale aiguë du bouton se manifeste par une occlusion intestinale, un état de choc septique, un plomb péritoné, une douleur abdominale et une hémorragie digestive.

Il n'y a pas d'hémorragie digestive. Il n'y a que la douleur abdominale. Elle est du bouton.

L'hémorragie digestive, c'est lorsqu'elle a un infarctus médical. D'accord? OK. C'est D. Il n'y a que D ici.

Restez avec moi. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Oui, professeur. D'accord.

Mais moi, je vais essayer de récupérer. Si vous avez des questions sur les autres coups, vous pouvez les écrire. Pas de soucis.

Où est-ce qu'il est, là? OK. Vous arrivez à voir? D'accord. OK.

Donc, un volontaire, M. E. C'est vrai. Il est venu de Connecticut, chez nous. Il a 64 ans.

Il se présentait pour un lecteur qui était en UQE. C'est que Belrithi Mohamed. Quel mécanisme? On peut expliquer par un hyperpéristaltisme.

D'accord? La souffrance intestinale, ça fait un hyperpéristaltisme et ça donne une diarrhée motrice. OK? Donc, on a 64 ans qui présente un licter, un prurit, des urines françaises, celles colorées, une asthémie avec un amérisme. On ne le fait pas.

On le faisait tout le temps parce que ça, c'est la question de licter. C'est vrai que licter, c'est une grande question. Vous allez la voir depuis licter néonatale en pédiatrie, en néonatalogie, jusqu'à licter en hématologie, jusqu'à licter médical en gastro- ontologie, en hépatologie, jusqu'à licter chirurgical chez nous.

C'est très... Mais on va essayer de vous montrer qu'ici, licter en chirurgie, c'est un obstacle. Ce n'est pas un... On avait licter, on a une cholestase, urines françaises, celles colorées, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle à l'écoulement de la bile dans les voies biliaires. Dites-moi ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je ne me souviens pas.

C'est ça. Elle est d'un seul tenant. Il a un licter depuis quelques jours, une dizaine de jours.

D'accord? On demande ça et on demande sur toutes les urines françaises, sur tous les licters, les celles décolorées. Lorsque vous avez des celles qui sont blanchâtres, c'est que la bile ne passe pas dans l'intestin. C'est un licter qui est cholestatique.

Le prurit, c'est très important. Le prurit, c'est ce que le plus souvent on demande, mais ça précède parfois licter. Vous avez des celles, des acides biliaires qui se déposent en succutanée.

Chronique, oui, j'ai dit, mais oui, chronique, depuis quelques jours. La majorité, ils vous disent une semaine, une semaine, deux semaines, 20 jours. Voilà, ça c'est chronique.

D'accord. Avant d'arriver aux examens paracliniques, on va vous demander, on va vous faire l'examen clinique. Ici, dans la cambutaner, c'est le patient, c'est que vous avez quelqu'un qui vous envoie un patient, 64 ans, il a un licter, ou bien il vient, il se présente chez vous, j'ai un

licter, vous allez demander depuis quand, un jour, d'accord, vous avez des signes associés, des signes que ça ressent, les celles que vous ressentez, est-ce que vous avez une asthémie, anorexie, est-ce que vous avez senti quelque chose, est-ce que vous avez mal? D'accord.

Bon, on va examiner le patient, on va trouver à l'inspection un patient qui est bien, qui est apéritif, les constantes sont bien, on va trouver un licter très parlant, franc, conjonctival, la langue, et puis surtout, surtout de la peau, ça peut être jaunâtre, ça peut être vers le verdâtre, le plus souvent il sent ça. On va faire l'examen de l'abdomen, on va trouver un abdomen, on va essayer de faire, on va trouver une petite hepatomégalie, d'accord, avec la mesure sympathique, mais surtout ici, on va trouver une petite masse qui suit sur le bord inférieur du foie, et qui suit le foie dans ses mouvements, on va faire le diagnostic d'une grosse lésion. Parfois, on ne trouve pas ça, et on va s'aider d'autres choses, ok? Étape suivante, on va faire une échographie, et on va demander un bilan biologique, surtout un bilan hépatique.

Et lorsque vous avez un TARC, il ne faut jamais demander un taux de protobine, un TP, parce que c'est des gens qui ont un déficit en enzymes vitamino-cadépendants, parce qu'ils peuvent passer par la bile, c'est des gens qui peuvent saigner. Donc, on va trouver une cholestase sur la bilirubine conjuguée, on dépend de la bilirubine conjuguée, c'est des gens, lorsque vous avez un TARC, c'est des taux qui sont un petit peu très élevés, et surtout, l'échographie, qui est très importante. Cliniquement, vous avez la grosse visicule, c'est en faveur d'un obstacle en aval de l'abouchement des cystiques, ça peut être une lésion de la voie biliaire, du colédoc, une adénopathie, une tumeur de l'estomac, mais par ordre de fréquence, c'est le cancer du pancréas qui est le plus fréquent.

En commençant à le voir souvent, il faut s'attendre que d'ici quelques années, en 2030, en 2035, il va être le premier cancer digestif. C'est les études épidémiologiques qui ont montré ça. Donc, on va avoir à faire à lui.

Nous, on a à faire à lui. C'est un cancer qui est très méchant, très difficile à gérer. Ici, l'échographie, pour moi, l'échographie qui est bien faite, lorsque j'ai un ictère cholestatique avec dilatation des voies biliaires intrahépatiques, intrahépatiques et extrahépatiques, je suis dans l'ictère obstétrique.

C'est qu'il y a un obstacle. C'est ce qu'on appelle les ictères qui vont être traités par chirurgie. On disait les états chirurgicaux, mais ça peut être endoscopique.

J'ai un obstacle ici. Étape suivante. Oui, on peut faire ça.

On peut faire ça. Dans les années 2000, il y a 20 ans, il y avait la fin des années, en tout cas 2000, mais avant, quelques années avant 2000, 1987, 1994, 15, 16 et après 2000, il y avait pas mal d'études qui comparaissaient IRM et endoscopie. IRM, scanner, scanner et endoscopie.

Et on faisait la part des choses. À un certain moment, à un certain moment, à un certain moment,

c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était l'IRM, la bilirem qui était la meilleure, parce que il y avait le logiciel qui montrait les voies biliaires. C'était plus performant.

Mais maintenant, on est revenu, nous, parce qu'on est revenu au scanner. Mais je ne peux pas vous dire, nous, on commence par le scanner, mais je ne peux pas vous dire, c'est les études, que le scanner, le scanner, le scanner est le mieux que la bilirem. Chacun a des indications.

IRM, bilirem, ce n'est pas faux. Lorsque tu dis scanner, ce n'est pas faux. Et parfois, la majorité des patients, ils ont, dans les pays développés, ils ont le scanner, l'IRM, l'endoscopie.

On peut faire la part des choses. Maintenant, le meilleur examen, au départ, c'est le scanner, mais ce qu'on appelle le scanner pancréatique. On dit, nous, on dit TDM abdominale, mais il y a un scanner présent.

Le scanner, le scanner, les nouveaux scanners, ils sont très performants, ils vont montrer, c'est des copes qui sont millimétrées, ils vont montrer ça, et ça peut faire le diagnostic, le bilan d'extension locale générale, et surtout, le bilan d'extension générale. Je vais avancer. Le scanner.

Il y a quelqu'un qui voit quelque chose ? C'est quoi ça ? Ça, c'est la voie. C'est quoi ça ? C'est là. Allez-y.

Yallah, c'est Mohamed. Non, c'est le temps artériel. C'est l'artère mésentérique supérieure.

Très bien, Mohamed. Je vais vous montrer c'est quoi. On va passer après, on va passer à l'anatomie, les rappels, et puis les images peropératoires.

Et je vais vous montrer pourquoi le pancréas, il fait peur. Pourquoi le traitement du cancer du pancréas, il est méchant. Pourquoi sa prison chère, il est difficile.

Donc, c'est cette situation. Ici, c'est la lésion pancréatique. Il suffit d'avoir une lésion de 3 cm qui devient difficile à traiter.

Ici, on a cette lésion. Ça permet de voir comme il faut. Le scanner le montre.

L'IRM aussi le montre. Mais ici, parfois, on fait l'ATDM, il est normal. Le monsieur, on peut commencer par le scanner, et on peut faire, lorsque j'ai un petit doute, on peut commencer par une bilirin.

Lorsque vous avez un patient jeune, on ne trouve rien. Et on fait la bilirin pour trouver une petite, ici, dans la voie biliaire, une petite lésion qui ne paraît pas, ou bien une petite tumeur de la voie biliaire principale, de la partie terminale de la voie biliaire principale, ou bien de la partie terminale du colédocle. Vous y êtes.

Maintenant, pour vous dire que les autres examens, ils ont leur place. Les chondoscopies, son

intérêt, c'est quoi? Les chondoscopies, c'est un examen, c'est vrai que les chondoscopies, c'est vrai la biopsie, mais il peut, il peut parfois, lorsque vous avez une lésion, il peut faire la part des choses. Est-ce qu'elle est tussulaire? Est-ce qu'elle est lithiasique? Est-ce qu'elle est hydrique? Les cas continu liquidiens.

Mais surtout, de voir les rapports avec les vaisseaux, avec les chondoscopies, on va voir les rapports très importants avec les vaisseaux, mais on commence à les voir avec le scanner, mais surtout, surtout à faire des biopsies. D'accord? Donc on doit faire le bilan d'extension parce que ça change toute la conduite à tenir et c'est des patients que l'on doit discuter, que l'on doit discuter dans une réunion de cancer. En effet, nous on le fait chaque semaine dans les pays d'Europe et c'est obligatoire parce que personne, je ne sais pas si vous avez ce message ou non, personne ne doit traiter un cancer tout seul, sauf dans une urgence.

Et malgré ça, il peut appeler les gens. Donc un cancer, il doit être pris en charge par les différents intervenants. Ici, il y a le gastroentérologue, il y a le radiologue, il y a le cancérologue, il y a le chirurgien, on peut avoir autre, il y a l'anapath qui va faire le prélèvement parce que le traitement d'un adénocarcine, c'est pas le traitement d'une tumeur neuroendocrine, c'est pas le traitement d'une tumeur bénigne, c'est pas la même chose.

Ce qu'on appelle, on doit prendre une sanction collégiale, une décision collégiale. On est d'accord et on va l'exposer aux patients, on va dire, on s'est réunis, on a discuté votre cas, vous avez ça et ça et ça, vous avez une tumeur, on va faire ce traitement, on va commencer par une chimiothérapie, on va faire une. Non, aucune aucune aucune pathologie n'a un aspect typique, je sais pas, sauf oui, le niveau hydraïque, mais parfois, on a même des surprises.

Mais je connais pas un cancer qui a un aspect typique. Toujours, on a des doutes. C'est pourquoi, ce qui est typique, parfois, c'est un stade avancé, on peut trouver une petite lésion et on a peur.

Parfois, on se, parce que on a une petite lésion, on doute, on refait le bilan, on refait le bilan, on sait pas quoi dire aux patients, on leur dit qu'il y a un doute. J'espère que j'ai répondu. D'accord.

Très bien. On peut commencer à avoir une chimiothérapie, mais surtout, je sais pas si on a lorsqu'on a une lésion, on fait un bilan d'extension, il y a une tumeur. Pas la CPRE, l'endoprothèse.

La CPRE, il a une indication, lorsque vous avez une tumeur de la voie biliaire principale. Ici, tu as une tumeur du pancréas, qui envahit l'ampoule, qui envahit le sphincter dodi. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait une endoprothèse pour laisser la bile descendre.

D'accord. Mais le traitement, lorsqu'on a, on doit éviter une biopsie, car ça peut induire une... Non. Non.

Les recommandations internationales, dans ces cas-là, avec les échondoscopies, on fait les biopsies et il n'y a pas de problème. La biopsie, on peut la faire par échondoscopie, comme on peut la faire par échographie, par scanner, ça c'est autre discussion. Mais c'est... La biopsie, c'est un... On la fait pour le foie, autre chose, on le dit, mais ici, dans les conduites, on fait une échondoscopie et on fait et on fait une biopsie.

Il faut savoir, dans ces cancers-là, ces dernières années, la chimiothérapie commence à être très performante. La majorité des cancers, surtout au niveau du pancréas, ils sont diagnostiqués à un stade tardif. Ils vont mieux commencer par une chimiothérapie, maîtriser la pathologie tumorale et puis réduire le volume de la tumeur.

On aura une chirurgie plus carcinologique. C'est ça les protocoles. Il faut le retenir comme ça.

Et on a sauvé pas mal de patients comme ça. Écoutez, ce patient-là, on va l'opérer, on va faire ce qu'on appelle une DPC. On l'a fait, c'est bien.

Les gens qui sont dans le service, il y avait un patient qui vient d'être opéré, je vais passer ici. Non, je vais revenir. Donc on enlève la partie terminale de l'estomac.

Un petit bout, c'est pas la même image que vous avez dans le cours. On enlève la vesicule biliaire, on coupe la voie biliaire principale, le dédenom ici, et la tête du pancréas. Et lorsqu'on veut rétablir la continuité, on va faire une anesthésie avec le pancréas.

Ici, on a une anastomose pancréatico-jejunale. On peut faire le pancréas dans le genou ou bien dans l'estomac. Ici, hépatico-jejunale, on commence par celle-là et après, on va passer 20 cm à 30 cm.

On va faire ici le canal hépatico-main, la voie biliaire principale. D'accord? Après 60 cm, on va anastomoser celle-là dans l'estomac. C'est un montage.

On aura l'alimentation qui va descendre ici. Elle va descendre ici dans l'intestinal. Vous aurez la bile et les liquides pancréatiques qui sont capitaux pour la digestion.

Ils vont passer ici. Et on aura la digestion des animaux à ce niveau-là. Ok? Des questions? Ça, vous avez... J'espère que c'est... paramètre... Ah! C'est enregistré.

La difficulté du pancréas, c'est sa situation anatomique. Elle est très profonde. Elle est très... dans la loge des zones pancréatiques qu'on a vu en anatomie.

Après, il y a ces vaisseaux-là. Surtout les vaisseaux mesoenteriques supérieurs. C'est pas comme les vaisseaux mesoenteriques inférieurs qu'on peut couper l'ence avec.

Parce que le jejunum, il est capital pour la vie. Moi, je disais qu'on ne pouvait pas vivre sans jejunum. Ici, au Maroc, on ne peut pas vivre sans jejunum.

Mais dans les pays européens, j'ai trouvé des gens qui pouvaient vivre sans jejunum. Ok? Et puis, surtout ici, la tête, ça fait 3-4 cm. Dès que vous avez une petite lésion, qui va envahir et la voie biliaire principale, et le canal de Versailles, et les vaisseaux mésentériques supérieurs.

Toutes les difficultés. Et puis, le pancréas, il est très friable. Et la fissure pancréatique, lorsque vous avez une fuite du suc pancréatique, il est très agressif.

Ça fait des dégâts sur les organes avoisinants. Donc, cette particularité anatomique et physiologique du pancréas fait toute sa difficulté. La chirurgie du pancréas, ça se fait que dans les grands centres.

Est-ce que la chirurgie est impossible de vaincre? Non. Qu'est-ce que j'ai montré? Non. On a fait la chirurgie.

C'est moi qui ai fait cette chirurgie. Ce n'est pas impossible. Quand est-ce que la question est d'accord? Non.

Quand est-ce qu'il est impossible? Il est impossible lorsque vous avez un envahissement. La veine, on peut la remplacer. La veine, on peut la remplacer.

On fait des sutures. On peut la remplacer. L'artère, on a commencé à la remplacer, mais lorsqu'il envahit ces vaisseaux-là, la chirurgie est impossible.

Lorsque vous avez une métastase hépatique ou bien une carcinose, la chirurgie est impossible parce que ça ne sert à rien. Et lorsque vous avez un patient très âgé qui ne peut pas supporter le geste chirurgical, la DPC, il ne peut pas la supporter. Là, ce qu'on dit, il y a les termes que l'on utilise en chirurgie.

Le patient non opérable, un patient qui avait un infarct qui est très altéré, qui est très âgé, on ne va pas faire une grande intervention pour lui parce qu'on risque. Donc, on dit le patient est non opérable. La tumeur, elle est non résécable.

C'est que la tumeur, elle est localement avancée. Elle est non avancée ou bien avec une carcinose ou bien une métastase. C'est ça ? D'accord.

La particularité de la chirurgie, c'est que c'est une hospitalisation qui est riche entre la maison thérapeutique supérieure et la gastro-durale. Ça fait toute la difficulté de la chirurgie pancréatique, mais quand même, on arrive à sauver des gens à la faire. Donc, ça, vous avez dans le cours.

J'espère que vous avez pas des questions. Il faut les apprendre. Ça, c'est des questions d'examen.

Ici, il n'y a pas l'alcool. Il y a le tabagisme. Il y a le diabète.

Et puis, il y a les lésions pré-cancéreuses. Pancréatite chronique, pas une pancréatite aiguë. Les TIPMP, le système a des nombres musculieux, pas serreux.

On arrive à voir des familles qui ont, dans plusieurs membres de la famille, qui ont des cancers de pancréas. C'est pourquoi la théorie de l'hérédité, il est mis en question. D'accord, ça, c'est les circonstances parce qu'on a englobé les tumeurs de la tête de pancréas et les tumeurs de la queue.

Mais l'ecteur dans la tête de pancréas, les douleurs, les douleurs, ou bien le ballonnement, c'est dans les deux. C'est pas un problème. Surtout lorsque vous avez quelqu'un qui a mal un petit peu.

Mais la majorité, lorsqu'il a mal un petit peu, la douleur est au second plan. Il faut penser au pancréas pour faire le diagnostic. D'accord, ça, vous l'avez dans la question.

Vous avez, tout à l'heure, on a parlé du bilan hépatique et du TP. Les marqueurs tumoraux, il faut les demander. Mais ils sont faussés.

Par exemple, c'est pas votre stade. Celui-là, le CA19-9A, il est faussé par la cholestase. Mais oubliez ça.

Mais vous pouvez le demander pour avoir une orientation de diagnostic. Donc, le bilan a demandé. D'accord.

On peut s'arrêter au scanner, mais on ne peut pas opérer un pancréas sans scanner. On peut s'aider à faire l'endoscopie pour l'IRM, faire la conjuration endoscopique, la CPRE ou bien l'endoscopie. Ça, on va la faire pour faire l'endoprothèse pour pouvoir fermer les sphincters.

Mais surtout, l'endoprothèse. Les diagnostics différentiels. D'accord.

Ici, ces deux-là, ces deux-là, ils sont des lésions précancéreuses. C'est un diagnostic différentiel, mais c'est un c'est pas un cancer, mais c'est des lésions précancéreuses. Il faut les traiter, savoir les traiter, faire le diagnostic et les traiter avant que ça dégénère.

C'est une grande discussion. Des questions? Des questions? Pourquoi est-ce l'utilisme? J'ai pas compris la question. Seulement? Non? Je sais pas, mais est-ce que j'ai répondu? Les facteurs qui sont ne sont pas considérés.

En médecine, c'est pas même parfois la logique. C'est les études épidémiologiques. Après tous les cancers du pancréas, on a trouvé que le tabac, la majorité des gens, ils ont le tabac, parce que j'ai la présentation dans les congrès internationaux, dans notre conseil, on a trouvé le tabac chez, je sais pas, 84%, l'alcool chez 16%, ça c'est épidémiologique.

Après on trouve les causes à effet. C'est comme maintenant, c'est comme la COVID. On a parlé

de ça et de ça, l'animal, ça et ça et ça, mais il y a des études épidémiologiques.

L'expliquer, je peux pas l'expliquer. L'éthylisme, il est incriminé dans les tumeurs hépatiques et dans tout ça. Mais reprenez que ça, vous vous êtes c'est que, ça c'est les études épidémiologiques.

C'est comme je vous ai dit que en 2030, en 2035, ça je le dis même aux chirurgiens dans les congrès, ils n'arrivent pas à assimiler. Mais quand vous avez le centre à Marseille, un centre de recherche en carcérologie, il a pris toutes les études épidémiologiques et l'a suivi l'humanité depuis maintenant 100 ans et on a trouvé que l'évolution, il y a des cancers qui vont, c'est comme les pathologies, des cancers qui vont disparaître un petit peu. Il y a des cancers qui vont apparaître et s'accroître, comme le cancer du pancréas.

Par contre, le cancer du col de l'utérus, ça persiste dans les pays développés chez nous, mais pas dans les pays développés. Le cancer de je ne sais pas, je ne vais pas dire autre chose, mais c'est comme ça, c'est les études épidémiologiques qui montrent ça. Donc, il nous reste 10 minutes.

Monsieur Cécile Franck, il y a 50 ans, épigastrologie chronique, asthénie, emménagement, amélioration, il en a fait une fibroscopie ou deux, c'était sans problème, on parlait des gastrites. Je ne sais pas si on a, il faut avoir ça en tête. Il faut demander, hein? Qu'est-ce qu'il faut demander? Ah oui, oui, il est un petit peu fréquent, mais on n'a pas de statistiques, parce qu'on n'a pas de registre de cancer.

Mais quand même, nous, on le voit. Moi, je le vois. Moi, je le vois, parce que c'est ma spécialité.

On est dans un centre hospitalier. Parce que je l'ai fait, les gens, nous l'ont, nous les envoient. Mais les autres, je crois, les autres spécialités, nous ne les voient pas.

Les petites structures, nous ne les voient pas. Où est-ce que j'étais comme ça? On va demander ici, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander un scanner. Un scanner, qu'est-ce qu'il montre? Vas-y, montre ça.

Une échographie, oui, on peut la demander. L'épazémie, l'épazémie, on peut la demander, mais lorsque vous avez, ce n'est pas une épigastrologie chronique. Chronique, ce n'est pas une aiguë, un abdomen aiguë.

Là, on va demander l'épazémie, parce qu'on suspecte une pauvreté aiguë. Mais si, on est on est dans dans dans l'épigastrologie chronique. Depuis, il vous dit que j'ai mal depuis quelques mois.

Depuis quelques mois. Parfois, ces gens-là dont je vous parle, ils n'ont même pas mal. J'ai un voisin, il a son frère, il est allé, c'est là-même à côté de moi.

Il n'avait pas mal. Le type, il est jeune. Le jeune, il a 57 ans.

Il jouait du foot chaque 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Il est peinard. Après, il est venu avec un petit peu, un picotement.

Et comme je l'ai vu cette semaine, il a une acide sur une tumeur de la queue des pancréas avec des métastases. Il n'a rien senti, lui. Il est bien.

Après, on a eu le diagnostic tactique. L'échographie, on peut la demander, mais moi, je demanderai un scanner. Parce que l'échographie, ici, lorsque l'on inspecte le pancréas, il est très difficile parce qu'il y a lésion digestive.

On peut la demander, mais on va demander un scanner. On ne va pas poser ces questions. L'échographie, vous allez la voir dans les gens qui vont faire la médecine familiale ou la médecine générale.

Ils vont avoir un échographe et ça va même faire partie de l'examen physique. Cette lésion-là, elle est là. Non.

Celle-là. Ici, c'est la tête du pancréas. Ça, c'est l'artère myzantérique supérieure.

Ici, c'est la queue du pancréas avec une image tessulaire. On peut la mesurer. Il fait 7-8 cm en bas.

De grands diamètres. Ici, le bout, le reste du bout de la queue du pancréas. Chez cette patiente-là, on va faire un bilan d'extension.

On va rechercher, est-ce qu'il y a des lésions hépatiques? Est-ce qu'il y a une ascite? On va voir les poumons. On peut demander les marques tumorales pour être orienté, pour la surveillance. Mais surtout, on peut faire autre chose.

Comment on peut avoir l'agnostic ici? Vous avez répondu tout à l'heure. Ici, regardez. Cette lésion-là, elle est accessible.

Ça, c'est l'estomac. L'écho-endoscopie. Ici, on peut faire une écho-endoscopie et faire la biopsie.

On a tout fait. On a discuté. On a opéré la patiente.

Ici, on a suspecté un tumor maligne. On a fait un splenopancréatectomycodal. Ça dépend.

Le traitement, ça dépend de la nature histologique. Est-ce qu'il va y avoir une chimiothérapie ou non? Et la surveillance. Parfois, lorsqu'on a une lésion un petit peu petite, dans l'anapathie, vous avez l'adénocarcinome, le plus fréquent et le plus méchant.

Vous avez les tumeurs l'orandocrine. Vous avez les tumeurs l'orandocrine. Vous avez les autres tumeurs spécifiques comme le glucocognome, l'insulinome.

Lorsqu'il y a une petite lésion, ça, c'est moi qui l'ai faite. Lorsqu'on a une petite lésion au niveau de l'isme, on peut faire ce qu'on appelle une pancréatectomie centrale. Parce qu'on ne veut pas enlever une grande partie.

Ça, c'est une lésion au niveau de l'isme. C'est très difficile. Regardez, ça, c'est le corps du pancréas.

Ça, c'est la tête du pancréas. Ça, c'est ma main. Je suis à droite.

C'est une pancréatectomie centrale. Donc, les différentes interventions que l'on va passer maintenant, vous avez l'adduction de nos pancréatectomies céphaliques. C'est pour la tête du pancréas.

Vous avez la splénopancréatectomie caudale pour les tumeurs malignes de la queue du pancréas. On peut faire une pancréatectomie caudale en conservant la rate. Mais ici, lorsqu'on a un cancer, on veut pour qu'on fait la splénopancréatectomie, on veut faire le curage ganglionnaire splénique ici.

C'est pourquoi on fait. Et lorsque vous avez une grosse tumeur, c'est difficile de conserver la rate parce que c'est difficile de disséquer ici dans les vaisseaux spléniques. Vous avez des questions? Quelles sont les diagnostics à évoquer devant des épigastralgies? Tout.

Gastrite, pancréatite chronique, tumeur bénigne, tumeur maligne, tout ce que vous voulez. Même l'infarctus humicale et les enjeux de poitrine. Lorsque vous avez des douleurs atroces, on suspecte une pathologie cardiaque.

Vous avez mal ici au niveau de l'épigastre. Vous pouvez avoir des lésions hépatiques du foie gauche. Tout ça.

Quelles sont les diagnostics à évoquer? On va tout discuter. Mais si vous avez une patiente qui a des épigastralgies, la théologie la plus fréquente, c'est quoi? C'est les gastrites, les ulcères. Lorsqu'il vous dit que j'ai mal parfois, il est stressé.

Vous me donnez la réponse. Le cancer de la peropcréase se manifeste habituellement par... Quand est-ce qu'on peut retenir le diagnostic de gastroenterite devant un patient présentant une douleur? C'est comme gastroenteritis. Lorsque vous mangez quelque chose, vous avez mal, des coliques, vous avez un abdomen qui est souple, vous avez des diarrhées, vous n'avez rien d'alarmant, un jeûne, pas de problème.

On va demander un traitement antalgique, antiseptique et on va attendre 24 heures, 48 heures. Mais lui, il a une diarrhée, des douleurs abdominales. On dit que c'est une gastroenterite.

Lorsqu'on a le doute, on va demander les examens par clinique. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? ABC, AC, ABC. Moi, je mettrais ABC.

Ben, la site, c'est possible, parce que la carcinose, on ne voit pas d'effet, il est possible dans les cancers de la tête et de l'arrière. Ce n'est pas mal. Mais si jamais je pose la question, le signe rencontré le plus souvent dans le cancer de la tête et de l'arrière, ça va être l'ictère.

Mais la question était, si ce manifeste souvent, habituellement, par l'ictère, une assiette, on mettrait ABC. Ben, si vous avez le doute sur la site, on peut l'enlever après. Bien.

Répondez à ça. Bien, bien fait. Bien, Ehsan.

Les... Ah oui, aussi. Vous avez les conférences passées en vous? Ah oui. D'accord.

BCB. Habituellement révélé par l'ictère, non. Parfois accompagné d'une assiette, oui.

Diagnostiqué à un stade précoce, non. Pourquoi non? Parce que, déjà, il est asymptomatique lorsqu'on fait le diagnostic. On disait que la queue des pancréas c'est plus facile, mais c'est pas facile.

C'est très méchant parce que ça fait pas mal et lorsqu'on le diagnostique, on le diagnostique à un stade tardif. C'est pourquoi vous avez C et D, c'est faux. Diagnostiqué à un stade tardif et de mauvais pronostic.

Donc, ici, C et D est faux. Et moi, j'ai des chiffres, non, rarement. D'accord? CB.

Ben, quelques images de tête. Ce patient-là, une grosse tumeur. Vous regardez ça? Ce patient-là, ben, je sais pas.

Il y a un patient qui avait une grosse tumeur. C'était non-risquable. On lui a donné une chimiothérapie.

Il était à 8 cm, 8, 9 cm et après, il est devenu à 2,7 cm et on l'a opéré encore vivant. Il y a un patient qui avait une tumeur maligne, mais c'était pas un adenocarcinome. On l'a envoyé comme ça.

Je crois que j'ai les images. Celle-là, regarde. Celle-là, c'est la tête du pancréas et ça, c'est le dieu du nom.

Ici, ça, c'est la veine porte. Ici, c'est la voie biliaire. D'accord.

Ici, c'est une des PC que vous avez dans le cours. Vous avez des questions? OK. Les questions de l'examen, elles vont être plus simples.

On essaiera de... Pour moi, les autres, je sais pas. Mais moi, c'est moi le coordinateur. Donc, les questions qui sont un petit peu compliquées, on va les faire.

Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et... Dommage que... Pour votre convention, on a été

condescentiels, mais les gens qui viennent chez nous, on est pris dans le service, mais c'est le panique qui prend en charge les mains.

Donc... Bien. Au revoir.